PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO

Ambulatório de Saúde Integral

Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/EBSERH)

1. Apresentação

O Ambulatório de Saúde Integral do HUB tem como propósito oferecer cuidado centrado na pessoa, com abordagem ampliada e coordenação do cuidado, especialmente para pacientes com necessidades complexas dentro da rede.

Este ambulatório atua como um **ponto estratégico de integração** entre:

- Especialidades hospitalares (do Hospital Universitário de Brasília)
- Atenção Primária à Saúde (APS)
- Serviços da rede do Distrito Federal e outros municípios (SES-DF e SES de outros Estados RIDE)

Seu foco não é substituir outros serviços, mas **articular o cuidado**, evitar fragmentação e garantir continuidade assistencial.

2. Objetivos

Objetivo geral

Oferecer atendimento ambulatorial com abordagem integral, promovendo coordenação do cuidado, racionalização de encaminhamentos e qualificação da assistência.

Objetivos específicos

- Coordenar o cuidado de pacientes com múltiplas condições
- Apoiar a transição do cuidado hospitalar → rede
- Reduzir encaminhamentos desnecessários
- Qualificar a comunicação entre os serviços
- Identificar precocemente situações de risco clínico
-

3. Princípios do ambulatório

- **Integralidade**: olhar para além da doença e oferecer respostas amplas para as demandas de saúde
- **Coordenação do cuidado**: organizar o percurso do paciente
- **Longitudinalidade possível**: mesmo em ambiente hospitalar
- **Equidade**: priorizar quem mais precisa
- **Racionalidade do uso de recursos**

4. Perfil dos pacientes

Critérios de inclusão

Serão atendidos pacientes:

- Classificados como **P3**
- De qualquer idade, sexo ou condição de saúde
- Que demandem abordagem integral e coordenação do cuidado

Prioridade para:

- Pacientes que necessitam coordenação do cuidado
- Pacientes em acompanhamento por múltiplas especialidades
- Pacientes com multimorbidade
- Pacientes em processo de transição para outros serviços

Critérios de exclusão

- Situações de urgência/emergência
- Demanda espontânea
- Pacientes não vinculados ao Hospital Universitário de Brasília (HUB)
- Pacientes já bem acompanhados na APS
- Condições de alta complexidade já coordenadas por especialidade (ex: oncologia, transplante)

5. Fluxo de entrada no ambulatório

Descrição do fluxo

> **Não definido**

6. Atendimento no ambulatório

6.1. Avaliação inicial

A consulta deve incluir:

- Escuta qualificada

- Levantamento de problemas (clínicos e não clínicos) dentro do paradigma biopsicossocial-religioso
- Revisão de comorbidades (avaliando se o tratamento está adequado de acordo com as melhores evidências científicas e protocolos mais recentes)
- Avaliação de uso de serviços (está vinculado a alguma UBS?)
- Identificação de lacunas no cuidado

6.2. Eixos da consulta

O atendimento deve considerar:

- Condições clínicas
- Saúde mental
- Contexto social
- Uso de medicamentos
- Rede de apoio
- Necessidade de articulação com outros serviços de saúde ou assistência social

7. Decisão clínica após atendimento

Após a consulta, o paciente pode seguir 4 caminhos:

1. Manter acompanhamento no ambulatório

- Quando há necessidade de coordenação contínua

2. Encaminhar para especialidade

- Quando há indicação clara e qualificada

3. Transição para APS ou outro serviço

- Quando condição está estável

4. Indicação de internação

- Quando identificado risco ou necessidade imediata

8. Encaminhamento para especialidades

Deve seguir os princípios do protocolo institucional:

- Encaminhar apenas quando necessário
- Incluir informações clínicas completas
- Classificar prioridade (quando aplicável)

Conteúdo mínimo do encaminhamento

- Problema clínico claro

- Tempo de evolução
- Exames relevantes
- Tratamentos já realizados
- Medicações em uso

Classificação de prioridade (resumida)

- 🔴 Vermelho: urgente (até 30 dias)
- 🟡 Amarelo: prioridade intermediária
- 🟢 Verde: pode aguardar
- 🔵 Azul: baixa prioridade

9. Fluxo de internação a partir do ambulatório

Quando identificado necessidade de internação:

9.1. Condutas imediatas

- Avaliar estabilidade clínica
- Identificar gravidade

9.2. Se urgência/emergência

Encaminhar imediatamente para o Centro de Pronto Atendimento (CPA):

Exemplos de sinais de gravidade:

- Instabilidade hemodinâmica
- Alteração do nível de consciência
- Insuficiência respiratória
- Dor intensa ou súbita
- Sinais neurológicos agudos

9.3. Se não urgente, mas necessita internação

- Solicitar vaga via regulação de leitos
- Definir especialidade de destino
- Realizar prescrição inicial

10. Transição do cuidado

Alta do ambulatório

Deve ocorrer quando:

- Problema resolvido ou estabilizado
- Cuidado pode ser feito na APS
- Não há necessidade de coordenação especializada

Boas práticas na alta

- Orientação clara ao paciente
- Registro no prontuário
- Comunicação com serviço de destino
- Plano de cuidado definido

11. Atribuições das equipes

Equipe do ambulatório

- Avaliar de forma integral
- Coordenar o cuidado
- Definir conduta e fluxos
- Comunicar com outros serviços

Equipe de destino

- Receber o caso com continuidade
- Garantir seguimento adequado

12. Considerações finais

O Ambulatório de Saúde Integral é um espaço estratégico dentro do hospital para reorganizar o cuidado, especialmente em contextos de fragmentação. Mais do que um local de consulta, ele funciona como um **espaço de articulação da rede**, com potencial de impacto direto na qualidade do cuidado e na experiência do paciente.